Entrevista

Projeto: Sistema de Gerenciamento e Triagem de Amostras Biológicas (BioAnálise)

Data: 21 de Setembro de 2026

Entrevistador: / Analista de ADS

Entrevistado: Dr. Roberto Silva (Biomédico Responsável pelo Laboratório BioAnálise)

Bloco 1: Abertura e Alinhamento de Expectativas

Entrevistador: Bom dia, Dr. Roberto, tudo bem? Sou a stakeholder da InovaCode e estou aqui para entender a dinâmica do seu trabalho e identificar as suas necessidades para laborar o melhor que sistema que atenda o que precise. Agradeço muito pela sua disponibilidade em nos receber.

Dr. Roberto: Bom dia! É um prazer. É ótimo ver o pessoal da Biomedicina aplicando tecnologia nos processos laboratoriais.

Entrevistador: Nosso objetivo hoje é entender o funcionamento geral do Laboratório BioAnálise, como vocês lidam com as amostras biológicas no dia a dia e quais são os maiores desafios que a falta de um sistema automatizado causa. Fique totalmente à vontade para explicar a rotina com suas palavras; não há respostas certas ou erradas.

Dr. Roberto: Perfeito, pode perguntar

Bloco 2: Entendimento do Domínio de Negócio (O Coração do Laboratório)

Entrevistador: Como funciona a rotina de atendimento em alto nível? Vocês fazem apenas a coleta local ou também recebem amostras externas?

Dr. Roberto: Nós fazemos a coleta na nossa sede e também recebemos amostras trazidas de três postos de coleta parceiros e de um hospital regional.

Entrevistador: Quais são os tipos de materiais biológicos mais coletados e manipulados diariamente?

Dr. Roberto: O maior volume é de sangue venoso — colhido em tubo EDTA roxo para hematologia, tubo seco com gel para bioquímica/sorologia e tubo de citrato azul para coagulação. Também recebemos bastante urina e fezes, além de algumas amostras pontuais de líquor.

Entrevistador: Poderia me descrever o ciclo de vida de uma amostra, desde a recepção até a análise?

Dr. Roberto: O paciente chega, a recepção faz o cadastro e imprime a etiqueta. O coletor retira o material, os tubos são organizados em caixas térmicas e levados para a bancada de Triagem. Lá, o biomédico confere a

integridade da amostra e libera o tubo para ser centrafugado ou enviado diretamente para os setores analíticos (Hematologia, Bioquímica, Microbiologia).

Bloco 3: Identificação de Dores e Gargalos (Problemas Atuais)

Entrevistador: Como vocês controlam hoje a identificação dos tubos e a estabilidade temporal dessas amostras?

Dr. Roberto: Infelizmente, ainda usamos planilhas manuais no Excel combinadas com anotações em livro de papel na bancada de recepção. Não temos controle automatizado de tempo de bancada.

Entrevistador: Onde ocorrem os maiores erros ou gargalos nessa operação?

Dr. Roberto: O nosso grande gargalo é a fase pré-analítica. Temos problemas com amostras hemolisadas ou com volume insuficiente que entram no setor analítico sem serem barradas na triagem. Além disso, por conta do controle manual, alguns tubos de hematologia ficam na bancada além das 4 a 6 horas limite, perdendo a estabilidade celular sem que a gente perceba a tempo.

Entrevistador: De que forma esses problemas afetam o dia a dia da equipe e os pacientes?

Dr. Roberto: Isso gera atraso nos laudos, desperdício de reagentes quando rodamos amostras inadequadas, e o pior: a necessidade de recocar o paciente por erro de triagem, o que prejudica nossa credibilidade.

Bloco 4: Levantamento de Necessidades para a Nova Solução

Entrevistador: Se você pudesse ver o novo sistema pronto amanhã, qual seria a principal mudança na rotina?

Dr. Roberto: Quero que o biomédico consiga validar rapidamente a qualidade da amostra na tela e que o sistema me avise visualmente se algum tubo estiver perto de vencer o prazo de estabilidade.

Entrevistador: Quais módulos ou etapas precisam obrigatoriamente estar integrados?

Dr. Roberto: Precisamos do módulo de Cadastro/Recepção de Amostras com código único, o módulo de Triagem e Qualidade (onde marcamos se o tubo foi Aprovado ou Rejeitado por hemólise, lipemia, tubo incorreto, etc.) e o acompanhamento do tempo de vida útil do tubo.

Entrevistador: Quais indicadores você gostaria de ver em um painel/dashboard logo ao abrir o sistema pela manhã?

Dr. Roberto: Gostaria de ver: quantidade de amostras pendentes na triagem, taxa de amostras rejeitadas no dia (com o motivo) e quantos tubos estão em alerta crítico de tempo de estabilidade.

Bloco 5: Usuários, Perfis e Restrições

Entrevistador: Quem serão os usuários do sistema e todos terão o mesmo nível de acesso?

Dr. Roberto: Teremos dois perfis principais: o Recepcionista/Coletor (que apenas cadastra e dá entrada no tubo) e o Biomédico Triador/Responsável Técnico (que tem autoridade para aprovar, rejeitar ou alterar o status da amostra).

Entrevistador: O sistema precisa se integrar com alguma ferramenta ou impressora específica?

Dr. Roberto: Sim, precisa enviar os dados para a impressora térmica de etiquetas para colar nos tubos no formato de código de barras.

Entrevistador: Quais os cuidados quanto à segurança e sigilo de dados sensíveis dos pacientes?

Dr. Roberto: Trabalhamos com dados de saúde protegidos pela LGPD e submetidos à RDC 302 da Anvisa. O acesso precisa ser individualizado por login/senha e com registro de logs para saber quem aprovou ou rejeitou cada amostra.

Bloco 6: Encerramento e Próximos Passos

Entrevistador: Resumindo o que anotamos: o foco principal de vocês é automatizar a fase pré-analítica, registrar critérios biológicos de rejeição (como hemólise e volume) e ter alertas visuais para a estabilidade temporal dos tubos. Está correto?

Dr. Roberto: Exatamente isso! Vocês captaram perfeitamente as nossas dores.

Entrevistador: Perfeito! Com base nesses dados, nossa equipe vai estruturar o Documento de Visão, os Requisitos Funcionais e os Protótipos de Tela. Agendaremos um retorno em breve para validar com você. Muito obrigado pela colaboração!

Dr. Roberto: Eu que agradeço. Bom trabalho para vocês!